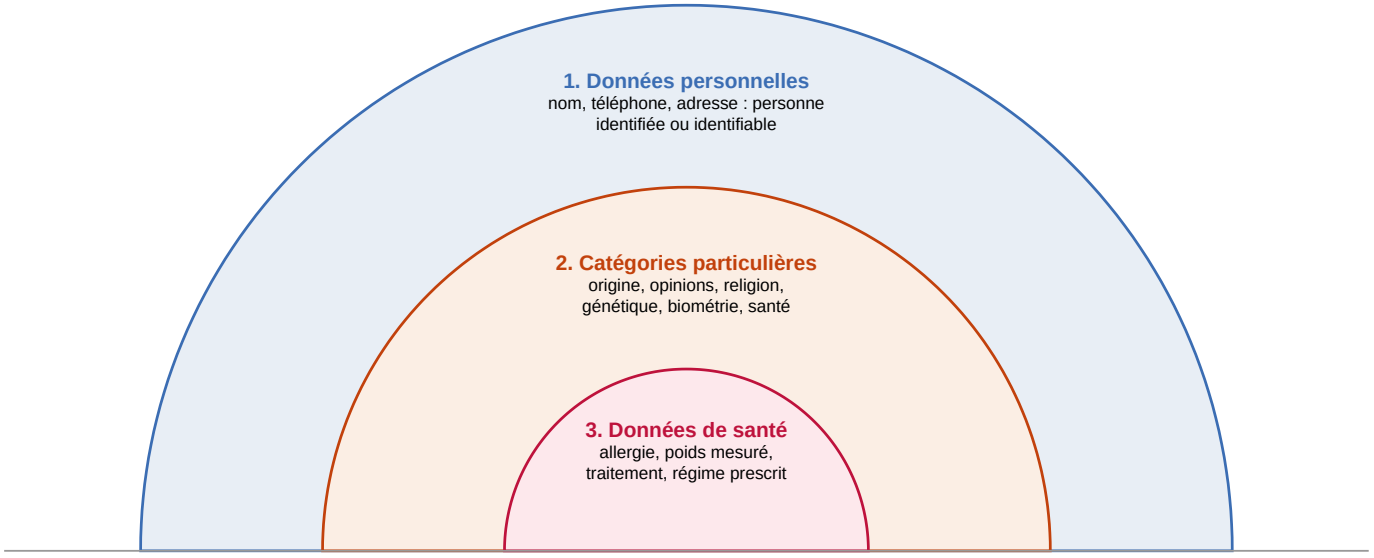
Les schémas du chapitre 20 à savoir refaire

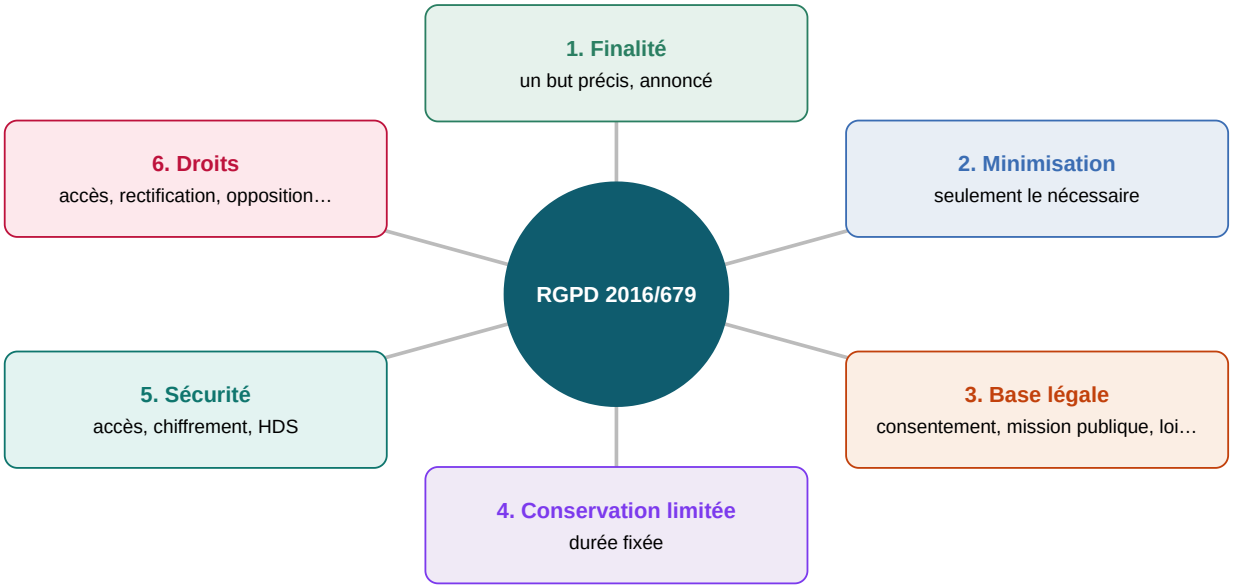
24 schémas qui peuvent tomber à l'écrit (schéma à légender ou à construire) ou être demandés à l'oral E5. Chaque schéma est suivi de ce qu'il faut dire.

1. Données personnelles et données de santé (20.3.1, figure 20.1 ; exercice 1 (figure 20.5))



Dire : article 9 du RGPD : traitement interdit par principe, sauf consentement explicite, soins, santé publique, recherche encadrée. Santé par nature, par croisement, par destination.

2. Les six principes du RGPD (20.3.1, figure 20.2 ; exercice 2 (figure 20.6))



Dire : adopté le 27/4/2016, applicable le 25/5/2018 ; principe de responsabilité : registre, AIPD, contrats, preuves. CNIL : 20 M€ ou 4 % du CA mondial.

3. Des textes de 1978 à aujourd'hui (20.3.1 ; exercice 20.1)



Directive = à transposer ; règlement = s'applique directement

Dire : loi 2018-493 du 20/6/2018 adapte la loi de 1978. Erreur fréquente : « le RGPD date de 2018 ».

4. Donnée de santé : trois façons de la reconnaître (20.3.1 ; exercice 20.3)

Par nature

- diagnostic, allergie
- HbA1c, régime prescrit
- intolérance au lactose

Par croisement

- poids + taille + suivi
- pas + rythme cardiaque + sommeil
- IMC sur un site minceur

Par destination

- photo d'assiette
- pour évaluer une dénutrition
- relevé alimentaire de 3 jours

Dire : l'étiquette « bien-être » ne change rien, c'est l'usage qui compte. Âge + commune seuls : pas une donnée de santé.

5. Les acteurs d'un traitement (20.3.1 ; exercice 20.4)

Acteur	Rôle	Texte
Responsable de traitement	décide des finalités et des moyens	RGPD art. 24
Responsables conjoints	accord : qui informe, qui répond, violation	art. 26
Sous-traitant	agit sur instruction écrite, contrat	art. 28
DPO	conseille, contrôle, contact des personnes	art. 37-39
Destinataire	reçoit les données	art. 4

Dire : la diététicienne qui intervient pour un club et l'éditeur d'un logiciel sont des sous-traitants. Article 25 : protection dès la conception et par défaut (15 → 5 champs = − 66,7 %).

6. Hébergement et choix d'un logiciel (20.3.1 ; exercices 20.6 et 20.10)

1	**Où sont les données ?**	UE, hébergeur certifié HDS (L. 1111-8), référentiel 2024 : EEE
2	**Qui y accède ?**	profils, éditeur, sous-traitants ultérieurs
3	**Quel contrat ?**	article 28 du RGPD
4	**Autres usages ?**	publicité, entraînement d'IA : non
5	**Et à la fin ?**	réversibilité : récupérer ses données
6	**Les droits ?**	fonctions d'accès, d'export, d'effacement

Dire : jamais de messagerie personnelle ni de stockage grand public. Transferts hors UE : Data Privacy Framework (10/7/2023) ; Safe Harbor (2015) et Privacy Shield (2020) annulés.

7. Durées de conservation du dossier (20.3.1 ; exercice 20.9)

Situation	Règle (R. 1112-7 CSP)	Exemple
Cas général	20 ans après le dernier passage	12/3/2026 → 12/3/2046
Mineur	jusqu'à ses 28 ans si plus tard	né le 4/9/2020 → 4/9/2048
Décès < 10 ans après le dernier passage	10 ans après le décès	décès 3/1/2030 → 3/1/2040
Fichier d'atelier	durée courte	fin du cycle

Dire : l'effacement du dossier médical est impossible pendant cette durée ; une fiche d'inscription peut être effacée.

8. Le secret et le partage (20.3.2, figure 20.3 ; exercice 3 (figure 20.7))

1. Équipe de soins
- strictement nécessaire
- patient informé
- peut s'opposer

2. MSSanté
- messagerie sécurisée
- annuaire, chiffrement
- objet neutre

3. Mon espace santé
- dossier, messagerie
- historique des accès
- masquage

4. Hors équipe
- consentement préalable
- sinon : rien

Dire : secret L. 1110-4 CSP ; diététicien L. 4371-1 ; article 226-13 du Code pénal : 1 an et 15 000 €. Il couvre ce qui est confié, vu, entendu, compris.

9. Le droit d'accès au dossier (20.3.2 ; exercices 20.11 et 20.12)

Demande
identité vérifiée, date notée

→

≥ 48 h
délai de réflexion

→

≤ 8 jours
cas général

→

≤ 2 mois
informations de plus de 5 ans

Article L. 1111-7 CSP (loi du 4/3/2002) ; ayants droit : causes du décès, mémoire, droits

Dire : demande le 5/11/2026 → pas avant le 7/11, au plus tard le 13/11 ; dossier ancien → 5/1/2027. La fille d'une patiente vivante n'a pas accès sans son accord.

10. Mon espace santé et MSSanté (20.3.2 ; exercices 20.13 et 20.14)

Mon espace santé
- dossier médical (ex-DMP)
- profil, messagerie, agenda
- ouvert début 2022

Contrôle du patient
- masquer un document
- bloquer un professionnel
- historique, bris de glace

Bon message MSSanté
- objet neutre
- traits d'identité
- le nécessaire, PDF

Dire : loi du 24/7/2019 ; 6 semaines pour s'opposer à l'ouverture ; matrice d'habilitation (qui voit quoi).

11. Une violation de données (20.3.2 ; exercice 20.19 ; cas guidé 4)

1	Découverte	noter l'heure : départ du délai
2	Premiers gestes	débrancher sans éteindre, ne pas payer, prestataire, DPO
3	CNIL en 72 h	week-end compris (art. 33) ; notifier puis compléter
4	Personnes	si risque élevé, dans les meilleurs délais (art. 34)
5	ARS	incident grave de sécurité (décret 2016-1214)
6	Après	plainte, registre des violations, prévention

Dire : vendredi 16 h → lundi 16 h ; mardi 8 h 30 → vendredi 8 h 30. Le registre des violations est obligatoire même sans notification.

12. Le virage numérique (20.3.3 ; exercice 20.20)

Avril 2019
Ma santé 2022

→ **Juillet 2020**
Ségur : 2 Md€

→ **1/1/2021**
INS obligatoire

→ **Début 2022**
Mon espace santé

→ **Mai 2023**
feuille de route 2023-2027

Correction CNED : la stratégie « e-santé 2020 » est dépassée

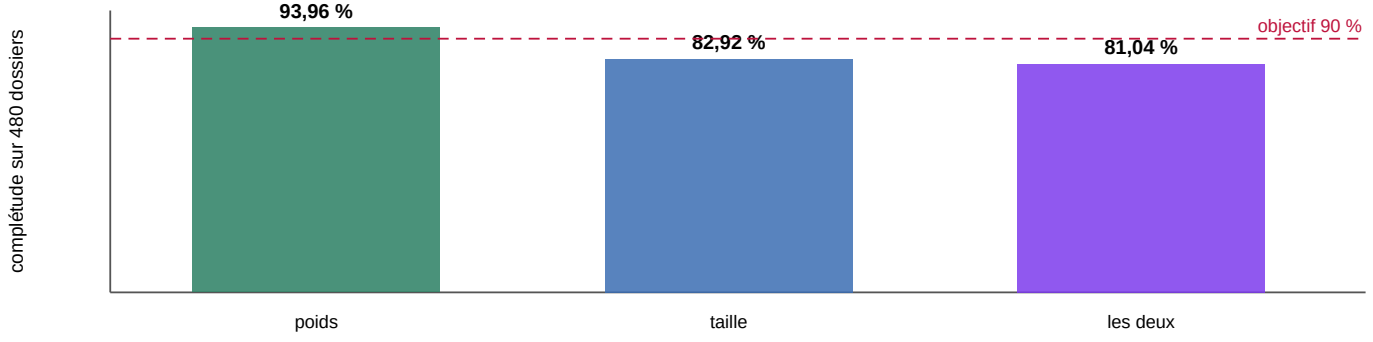
Dire : loi 2019-774 du 24/7/2019 ; télésanté = télémédecine + télésoin (diététicien, décret 2021-707). Interopérabilité : 9 200 min = 153,3 h gagnées.

13. Pseudonymiser n'est pas anonymiser (20.3.3 ; cas guidé 3)

Pseudonymisé	Anonymisé	Bases
• code à la place du nom • réidentification possible • le RGPD s'applique	• identification impossible • irréversible • hors RGPD	• SNDS (2016, élargi 2019) • Health Data Hub (2019) • EDS : référentiel CNIL 2021

Dire : Cegedim Santé, 800 000 € (5/9/2024) : données pseudonymisées traitées comme anonymes. Étude interne ≠ recherche : la finalité décide.

14. Le k-anonymat et la qualité des données (20.3.3 ; exercices 20.22 et 20.23)



Dire : complétude = renseignés / examinés × 100. k-anonymat : chaque combinaison de quasi-identifiants concerne au moins k personnes ; k = 2 → regrouper ; seuil de publication 5 ou 10.

15. L'espace européen des données de santé (20.3.3 ; exercice 20.24)

Règlement 2025/327

- du 11/2/2025
- JOUE 5/3/2025
- en vigueur 26/3/2025

Usage primaire

- soins
- patient et soignants
- y compris dans un autre pays

Usage secondaire

- recherche, politiques
- organismes d'accès
- environnements sécurisés

Dire : jalons 26/3/2029 et 26/3/2031. Un résumé patient consultable par un médecin d'un autre pays de l'Union relève de ce règlement.

16. Comment fonctionne un modèle de langage (20.3.4 ; exercice 20.25)

Ce qu'il fait

- prédit la suite la plus probable
- reformule, résume
- propose des idées

Ce qu'il rate

- invente des références
- calcule mal
- connaissances datées

Hallucination

- réponse fausse
- donnée avec assurance
- pas un mensonge

Dire : lentilles cuites ou sèches ? On vérifie dans Ciqual. Potassium pour un dialysé, recommandations officielles : jamais sans source.

17. Les jeux de données (20.3.4 ; exercice 20.26)

Entraînement
le cours

→

Validation
les devoirs

→

Test
l'examen, une fois

→

Validation externe
un autre centre

Surapprentissage : appris par cœur, échoue sur des données nouvelles

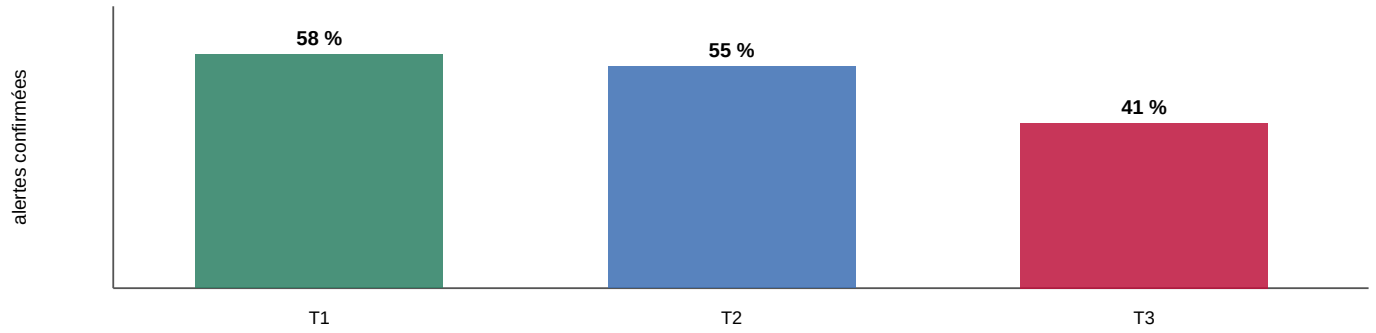
Dire : décalage entre données d'entraînement et d'usage (photos de restaurant → plats mixés de l'hôpital). Demander : données, test indépendant, définition HAS, fausses alertes.

18. L'exactitude peut tromper (20.3.4 ; exercice 20.27)

	Outil A (toujours « non »)	Outil B	Exercice 20.27
Exactitude	92,0 %	89,0 %	88,5 %
Sensibilité	0 %	75,0 %	80,0 %
Spécificité	100 %	90,2 %	90,0 %
VPP	sans objet	40,0 %	58,5 %
Alertes à vérifier	0	150	410 (60 manqués)

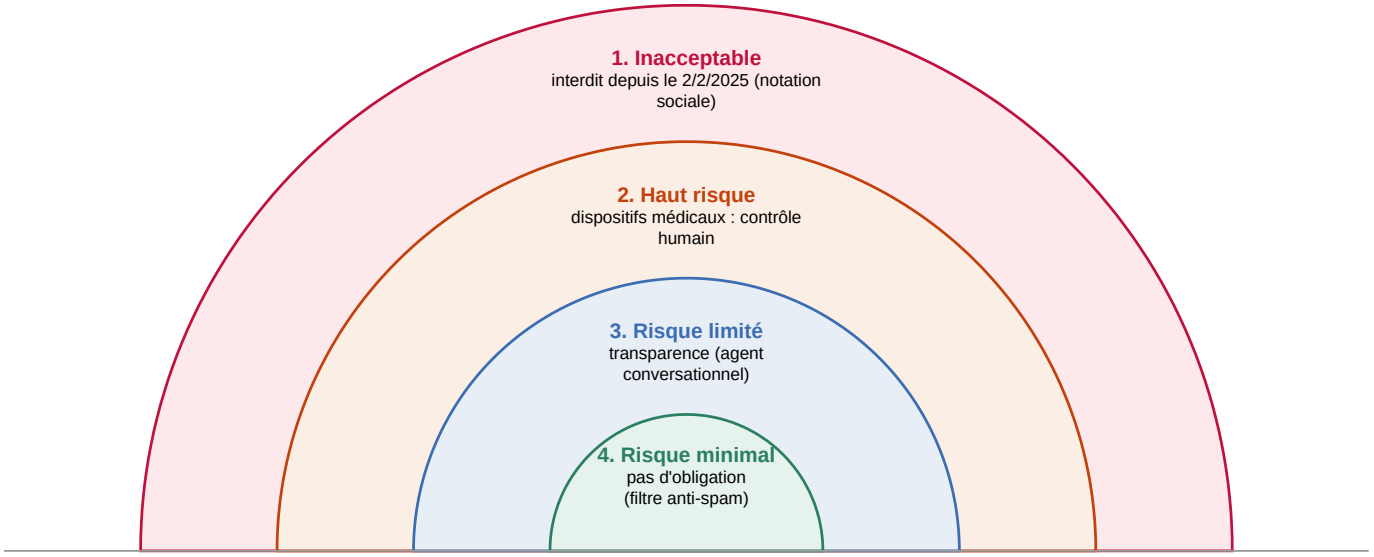
Dire : exactitude = (VP + VN) / total ; elle trompe quand la maladie est rare (8 % ici). Le dépistage clinique habituel est gardé.

19. Biais, dérive, décision humaine (20.3.4 ; exercices 20.28 et 20.29)



Dire : dérive = − 17 points (29,3 %) après l'ouverture de 12 lits de soins palliatifs. Biais : Sjoding 2020 (11,7 vs 3,6 %) ; Obermeyer 2019 (dépenses ≠ besoins). L. 4001-3 : informer le patient.

20. Le règlement européen sur l'IA (20.3.4, figure 20.4 ; exercice 4 (figure 20.8))



Dire : règlement 2024/1689 du 13/6/2024, en vigueur le 1/8/2024. Omnibus 2026/1744 : haut risque reporté au 2/12/2027 et au 2/8/2028 ; article 50 depuis le 2/8/2026.

21. Logiciel ou dispositif médical ? (20.3.4 ; exercices 20.34 et 20.35)

Logiciel	Finalité	Dispositif médical ?
Carnet de recettes	informer	non
Journal « pour mieux manger »	bien-être	non, en principe
Calcul du bolus d'insuline	décider d'un traitement	oui (classe élevée)
Repérage de la dénutrition	aider au diagnostic	oui, au moins IIa
Réglage d'une pompe parentérale	administrer un traitement	oui, IIb ou III

Dire : règlement 2017/745 (26/5/2021), marquage CE, ANSM. Règle 11 : décision → IIa ; grave → IIb ; mort ou irréversible → III. Organisme notifié dès IIa. Matériovigilance.

22. Les repères A.V.E.C. de la HAS (20.3.4 ; exercices 20.37 et 20.38)

Apprendre	Vérifier	Estimer	Communiquer
• se former • limites de l'outil • règles de la structure	• valeurs (Ciqual) • recommandations datées • références	• temps gagné • erreurs corrigées • bénéfice réel	• équipe • patients • mention sur le support

Dire : HAS, 30/10/2025. Un guide n'est pas une autorisation. Consigne : rôle, contexte, tâche, format, contraintes ; jamais de données nominatives. Tracer chaque usage.

23. L'identité nationale de santé (20.4.2 ; exercice 20.51)

Statut	Téléservice INSi ?	Pièce d'identité vérifiée ?
Provisoire	non	non
Récupérée	oui	non
Validée	non	oui
Qualifiée	oui	oui

Dire : INS obligatoire au 1/1/2021 (décret 2019-1036) : matricule + 5 traits. La carte Vitale n'est pas une pièce d'identité. Identitovigilance : le patient dit lui-même son nom.

24. Méthode de l'écrit sur le numérique (20.8 ; exercice 20.71)

1	**Les données**	lesquelles, sur qui, de santé ou non ?
2	**Les acteurs**	responsable, sous-traitant, destinataire
3	**Les règles**	finalité, minimisation, base légale, sécurité, durée, droits, secret
4	**Le calcul**	taux, délais, coûts, montrés
5	**Les mesures**	par priorité, avec le texte
6	**La conclusion**	l'outil propose, le professionnel décide

Dire : le jury attend des textes nommés et datés, la minimisation, le bon canal, des chiffres justes et un regard critique sur l'IA.